

Les contusions abdominales



Dr Mamadou Cissé

Professeur Titulaire

Chirurgie Générale HALD, Module Digestif, 2016-2017

Objectifs

À **Enoncer** la physiopathologie des lésions des organes pleins dans une CA

À

À **Décrire** les différentes étapes de l'examen clinique dans une CA à l'étape hospitalière

À

Citer 5 apports du scanner dans les CA

À

À **Définir** la CAT appropriée devant les trois situations cliniques des CA

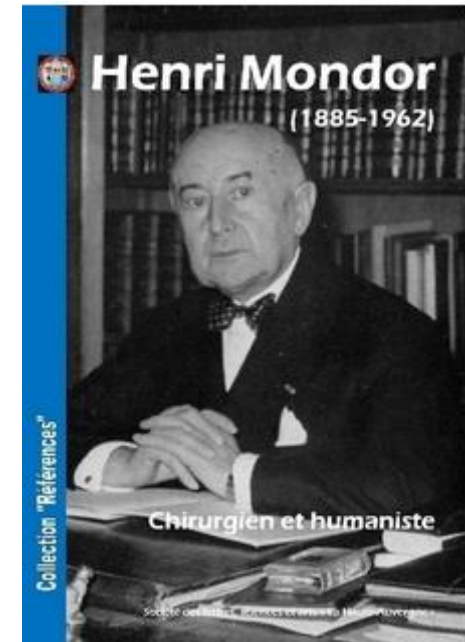
À **Décrire** les indications et les conditions du traitement non opératoire dans les CA

À **Citer** les indications du traitement chirurgical en urgence

Une contusion abdominale peut tuer:

- ❖ En quelques **minutes**, par choc ou hémorragie foudroyante
- ❖ En quelques **heures**, par hémorragie interne plus lente
- ❖ En vingt-quatre heures , **quarante-huit heures**, par péritonite généralisée ou hémorragie en **deux temps**.

Henri Mondor(Diagnostics urgents,1928)



Définition

On appelle contusion abdominale un **traumatisme fermé** de l'abdomen.

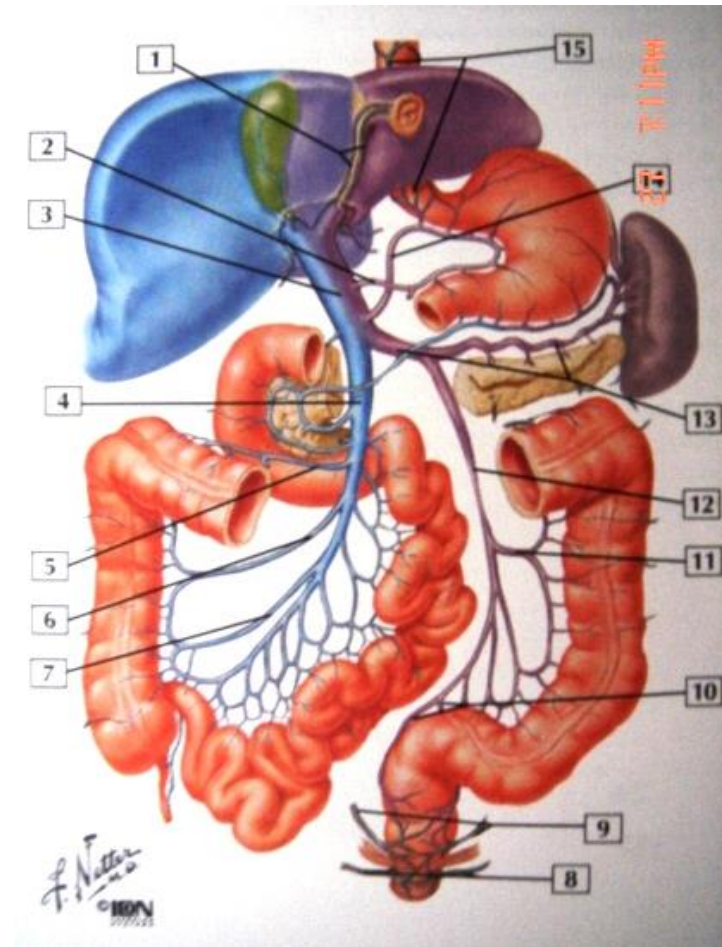
Il faut les différencier des plaies abdominales qui sont des traumatismes ouverts

Anatomie

À Viscères pleins
(hémopéritoine)

À Viscères creux (péritonite)

À Mésentère , mésos
(dévascularisation)



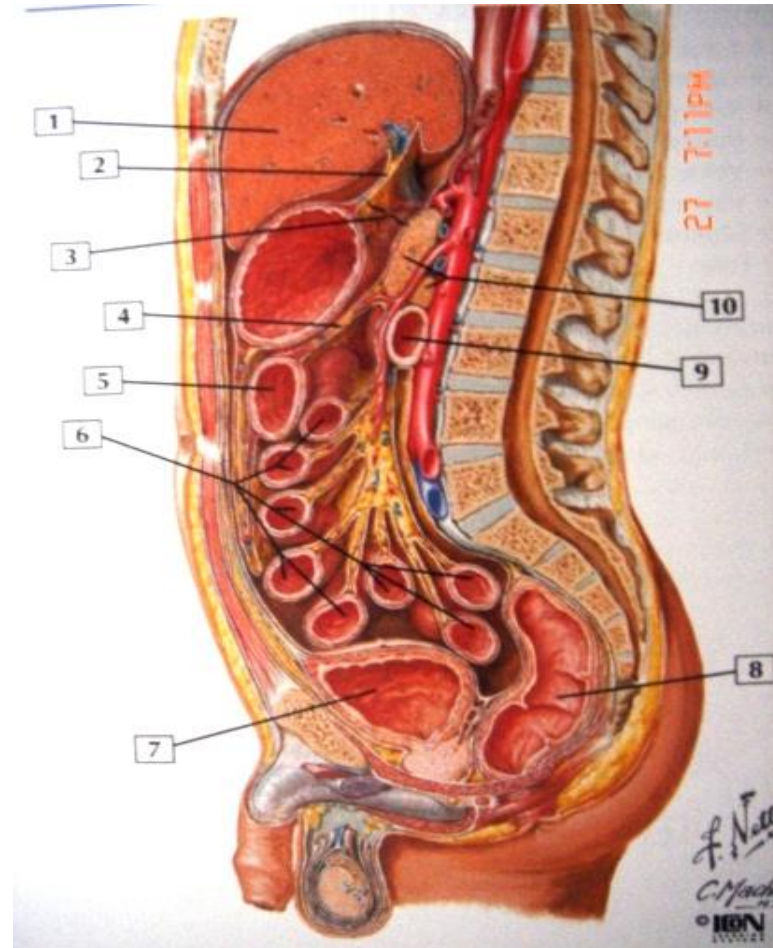
Anatomie

À **Rachis dorsolumbaire:** billot

À **Régions frontières:** thorax et pelvis

À **Espaces**

- intra péritonéal
- rétro péritonéal
- pelvi-sous-péritonéal



Physiopathologie

Circonstances

Accident de la circulation+++

Chutes++

Tentative d'œautolyse

Accidents sport, du travail

Rixes etc.



Physiopathologie

Mécanismes

CHOC DIRECT

écrasement des organes
entre la force extérieure et le
plan postérieur.

Les lésions occasionnées
dépendent de l'impact et de la
résistance du plan postérieur.



Physiopathologie

Mécanismes

CHOC INDIRECT

❖ Décélération

- **Horizontale** (collision frontale)
- **Verticale** (chute d'un lieu élevé).



Arrachement de méso et de pédicules



Physiopathologie

Mécanismes

À Ceinture de sécurité



À Forces tangentielles

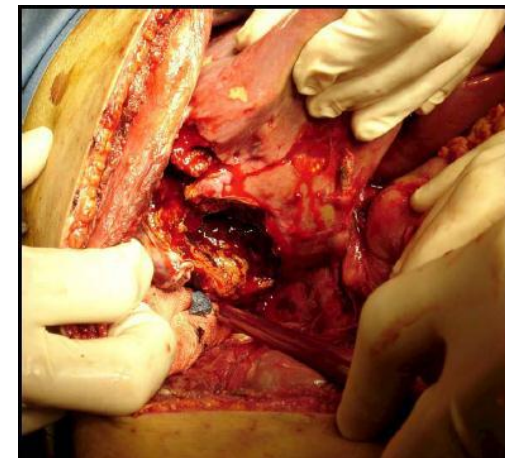
À Blast



Physiopathologie

Lésions rencontrées

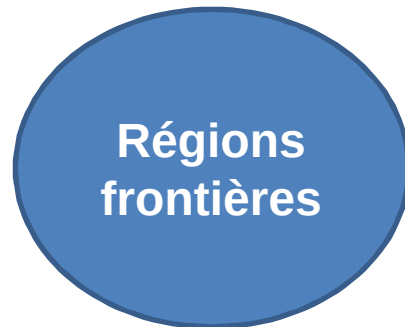
- contusion, éclatement, hématome
- fracture, avulsion
- rupture
- perforation, chute d'écaille
- arrachement vasculaire, mésentère



Physiopathologie

Polytraumatisme

Lésions associées

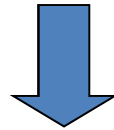


« Tout polytraumatisé a une contusion de l'abdomen jusqu'à preuve du contraire »

Physiopathologie

Conséquences

Choc hémorragique



Décompensation: cercle vicieux (**MOORE**)

Hypothermie, Acidose, Trouble coagulation



Défaillance multi viscérale

Physiopathologie

À Le syndrome du compartiment abdominal

Conséquences

- Diminution débit cardiaque
- Diminution compliance thoracique
- Dysfonctionnement rénal
- Augmentation pression intra crânienne
- Compression veineuse mésentérique

**À Conduite à tenir
diagnostique**

**À Étapes diagnostique et
thérapeutique intriquées**

ÅDiagnostic positif

Étape pré hospitalière

Trois objectifs

- ï Lever une détresse vitale immédiate
- ï Éviter d'aggraver les lésions initiales
- ï Convoyer le blessé vers une structure hospitalière.

A: airways

B: breathing

C: circulation

D: drugs

Étape hospitalière

Interrogatoire

À Sur l'accident

- ï date, heure, lieu, mécanismes, moyens et délai de transfert

À Sur l'accidenté

- ï état civil, antécédents, symptômes, état de jeun, soins reçus

Étape hospitalière

Examen clinique complet

- Examen général

Constantes

Etat de conscience

Coloration des muqueuses

Étape hospitalière

Examen physique

- **Inspection**: chercher
 - Des traces d'impact (hématome, éraflure), marque de la ceinture de sécurité (seatbelt mark sign)
 - Distension abdominale anormale
- **Palpation**: chercher
 - une douleur provoquée
 - Une défense, une contracture
 - Un hématome péri rénal (palper la région lombaire)

Étape hospitalière

Examen physique

- **Percussion**: matité des flancs, sonorité pré hépatique
- **Auscultation** et touchers pelviens(rectal et vaginal)
- Rechercher systématiquement une **hématurie** macroscopique ou microscopique
- **Examen systématique des autres appareils**:lésions associées (poly traumatisme)

Étape hospitalière

Biologie

- Groupage sanguin+++
- Numération formule sanguine+++
- bilan coagulation +++
- Ionogramme sanguin
- Amylasémie et transaminases
- Alcoolémie
- HCG
- Si nécessaire gaz du sang

Au terme de ce bilan clinique et biologique,

TROIS SITUATIONS POSSIBLES

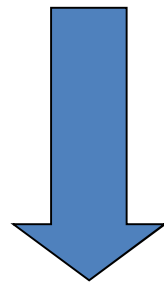


- À 1. **URGENCE OPERATOIRE EXTREME**
- À 2. EXAMEN CLINIQUE ANORMAL
- À 3. EXAMEN CLINIQUE NORMAL

Urgence opératoire extrême devant:

- UN CHOC HEMORRAGIQUE NON

CONTROLE: échec du remplissage+++



Chirurgie en urgence
Pas d'omagerie

À 1. URGENCE OPERATOIRE EXTREME

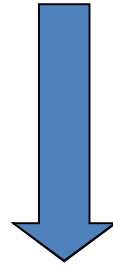
À 2. **EXAMEN CLINIQUE ANORMAL**

À 3. EXAMEN CLINIQUE NORMAL

Tableau clinique anormal mais patient stable

À Pas d'état de choc ou choc corrigé par le remplissage

À Mais examen clinique anormal: sans certitude diagnostique.



Explorations para cliniques

Surveillance clinique répétée concomitante

Explorations para cliniques

À Radiographie abdomen sans préparation(ASP)

- Pneumopéritoine?
- Rétro pneumopéritoine?
- Distension intestinale?
- Grisaille (épanchement)?

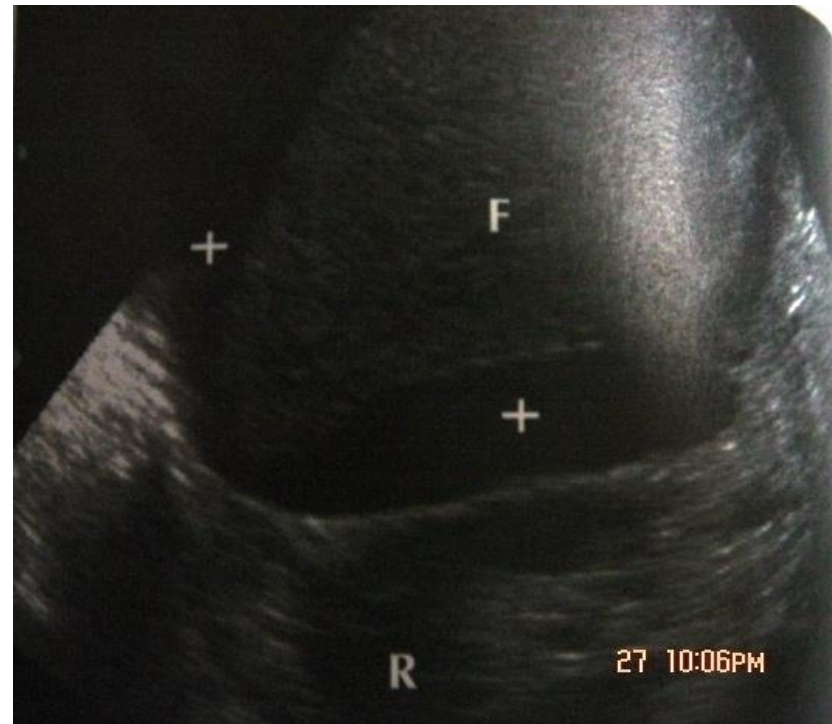
➡ **Peu de renseignements**



Explorations para cliniques

Échographie abdominale

- Epanchement?
- Lésions organes pleins?



Examen de première intention

Explorations para cliniques

Tomodensitométrie

Explore les parenchymes, non gênée par les gaz

- Montre les épanchements intra et rétro péritonéaux
- Analyse les lésions associées
- Apprécie valeur fonctionnelle des parenchymes

➡ **Examen de référence**



Explorations para cliniques

Ponction lavage du p ritoine (PLP)

  Technique

  Positivit 

-   Taux de GR > 100 000/mm³
-   Taux de GB > 1000/mm³
-   Pr sence de bile, de liquide digestif, de particules alimentaires, d' rine, de pus ou de germe.
-   Passage du liquide de lavage par un drain pleural ou la sonde v sicale

  Int r t face au scanner?

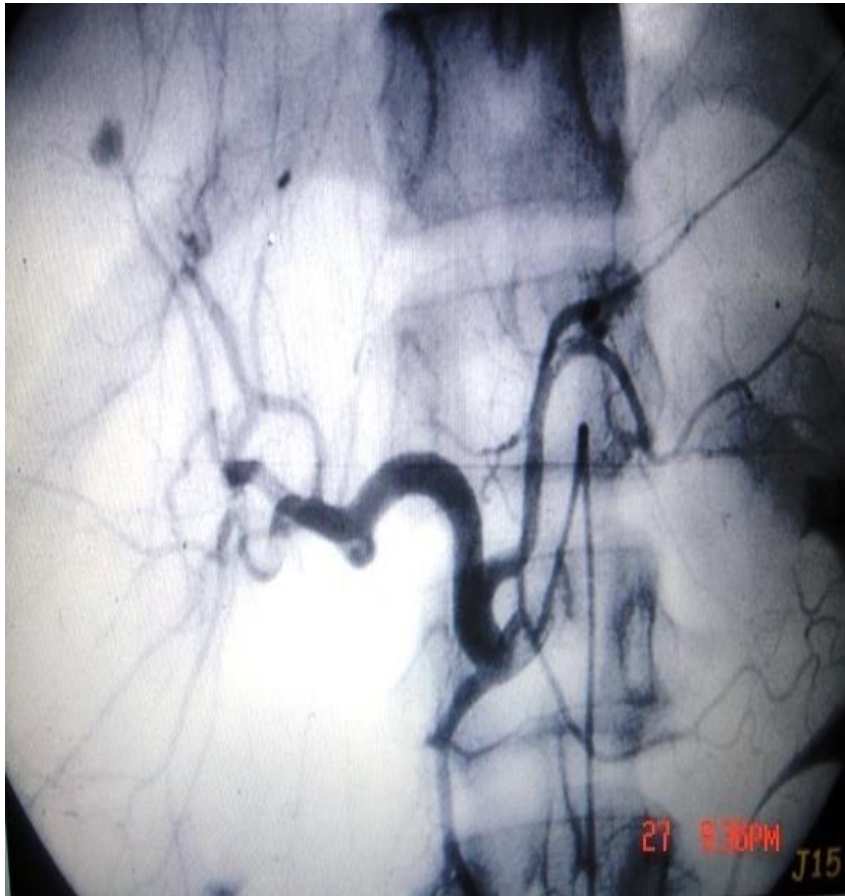
Explorations para cliniques

Artériographie

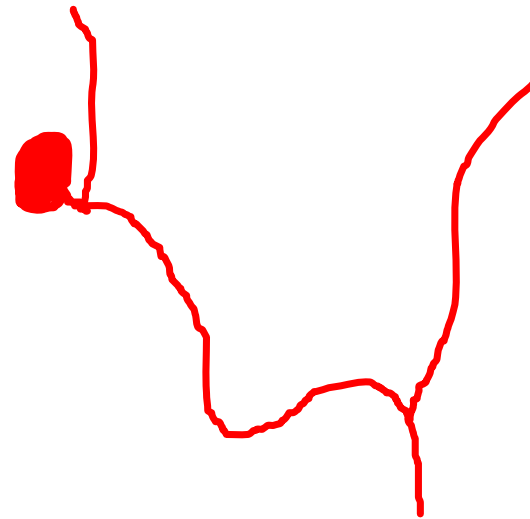
- À Examen invasif
- À Explore les axes artériels
- À Visée diagnostique
- À Visée **thérapeutique** (**Embolisation**)



Explorations para cliniques



À Artériographie



Côlioscopie

À Visée diagnostique et thérapeutique

À En cours d'évaluation

À Contre-indications

- ï Traumatisme crânien
- ï Patient instable



À 1. URGENCE OPERATOIRE EXTREME

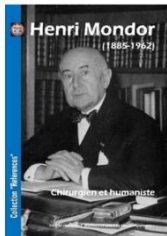
À 2. EXAMEN CLINIQUE ANORMAL

À 3. **EXAMEN CLINIQUE NORMAL**

Examen clinique normal

À Hospitalisation

À Surveillance en **milieu chirurgical** (minimum 48 heures)



But: Guetter des signes d'hémorragie secondaire ou de péritonite

À Conduite à tenir thérapeutique

Traitement

But

- À Préserver le pronostic vital du patient
- À Réparer au besoin les lésions
- À Eviter et traiter les complications

Traitement

À Moyens et méthodes

ï Moyens médicaux

À Réanimation+++

- ï Règle des 4 tuyaux

- ï Transfusion

- ï Réchauffer le patient

À Antalgique-antibiotiques, é .

Traitement

À Moyens radiologiques

- ï Artériographie + embolisation

Traitement

Traitement non opératoire

À Surveillance armée

À Conditions

À Possibilités examens cliniques, biologiques et radiologiques répétés

À Possibilité d'intervention urgente en cas de nécessité

Traitement

Moyens chirurgicaux

À Voie d'abord large: **laparotomie** +++, cî lioscopie?

À Exploration complète de la cavité abdominale

À Gestes: Hémostase-Arrêt contamination-Réparation

À **Laparotomie écourtée (sauvetage)**

Traitement

Moyens chirurgicaux

À Laparotomie écourtée (damage control)

« Écourter le stress chirurgical »

- ï **Gestes de sauvetage:** Packing, tamponnement, hémostase directe, agrafage segments digestifs
- ï **Fermeture** cutanée simple, sac de Bogota
- ï **Stabilisation** (USI)
- ï **Seconde intervention:** réparation définitive planifiée

Traitement

Packing



Sac de Bogota



Traitement

À Indications

À Choc hémorragique non contrôlé d'emblée ou secondairement

À Péritonite évidente

À Association avec d'autres lésions intra ou extra abdominales

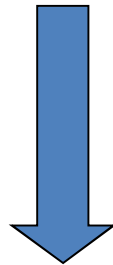


CHIRURGIE EN URGENCE

Traitement

Indications

À Hémorragie par atteinte d'un viscère plein (foie, rate) chez un patient **stable ou stabilisé avec absence d'autre lésion intra abdominale**

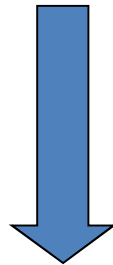


Traitement conservateur

Traitement

Indications

Lésion d'un viscère plein (foie, rate) chez un patient **stable ou stabilisé avec absence d'autre lésion intra abdominale**



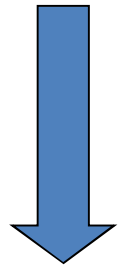
Traitement non opératoire

Si conditions réunies

Traitement

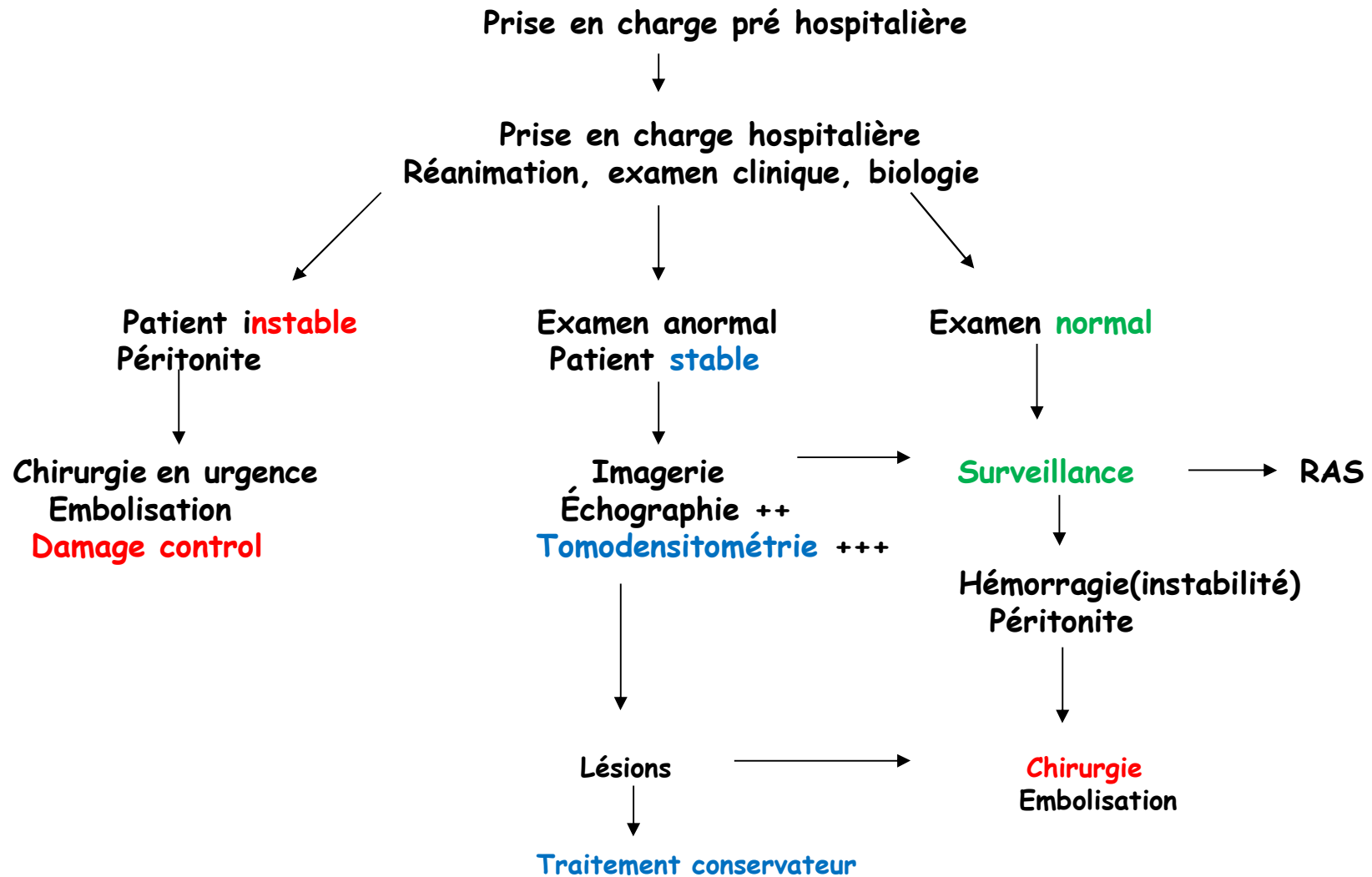
À Indications

- ï Saignement artériel objectivé par l'artériographie surtout avec lésions associées (traumatisme pelvien)



Embolisation

Arbre décisionnel
Contusion abdominale



CONCLUSION

À MEILLEURE CONNAISSANCE DES PHENOMENES
PHYSIOPATHOLOGIQUES

À PROGRES DE L'IMAGERIE

À TRAITEMENT CONSERVATEUR

À PRISE EN CHARGE PRE HOSPITALIERE

PREVENTION

